

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

1	1	1	0	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

CÓDIGO DE PROYECTO

- Investigador principal:** Nathaly Raquel Mendoza Morales / 960134583
/a2021101515@uwiener.edu.pe
- Nombres de los coinvestigadores:** Mg. Karina Diez Quevedo
- Facultad o unidad a la que pertenece:** Ciencias de la salud
- Línea de Investigación:** Salud y bienestar
- Nombre del proyecto:** Factores de riesgo asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el centro de salud Conde de la Vega Baja, 2023
- Tipo de estudio:** El estudio es de tipo retrospectivo.
- Tiempo esperado de duración (en meses):** 3 meses
- Resumen:**
El cáncer de cuello uterino es una neoplasia cuya causa predominante es el virus del papiloma humano (VPH), y representa un importante problema de salud en el Perú, debido a sus altas tasas de morbilidad y mortalidad. La situación presentada evidencia la necesidad de realizar estudios específicos para la realidad de cada establecimiento de salud, ya que los factores que se encuentran en la población varían notoriamente aún dentro de una misma región, y puede afectar el cumplimiento de las metas de las estrategias implementadas. El objetivo del estudio es analizar los factores asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima durante el año 2023; del cual se desprenden tres objetivos específicos concernientes a los factores sociodemográficos, obstétricos y personales. El estudio tendrá un diseño observacional de casos y controles, de tipo retrospectivo. La población estará integrada por las historias clínicas de las mujeres que se han realizado una prueba molecular de VPH en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja entre los meses de enero a diciembre del 2023, el cual, según reportes estadísticos del nosocomio, consta de 190 mujeres. La muestra estará formada por un grupo de casos con resultado positivo de VPH en la prueba molecular y un grupo de controles con resultado negativo para dicha prueba, y con un tamaño proporcional entre ambas. De acuerdo con la oficina de estadística del centro de salud, el número de resultados positivos fue de 28 usuarias. Se considerará una proporción de 3 a 1 para calcular el tamaño del grupo de controles, obteniendo así un número de 84. Entre ambos, el tamaño de muestra total será de 112 mujeres. La técnica a emplear será la revisión documental. El instrumento es una ficha de recolección conformada por 13 ítems, y dividido en dos partes. La primera parte corresponde a los factores asociados, los cuales están agrupados en tres secciones: factores demográficos con 5 ítems, factores obstétricos con 4 ítems y factores personales con 3 ítems. La segunda parte corresponde a la infección por VPH, y contiene sólo un ítem en el que se indicará el resultado de la prueba realizada a la participante, sea positivo o negativo. Los datos recogidos de las fichas de recolección serán trasladados en una base de datos del paquete estadístico SPSS versión 25 para su análisis, el cual se dividirá en una fase descriptiva y otra inferencial. En el análisis descriptivo se presentarán tablas de frecuencias y porcentajes de las variables consideradas en la investigación, comparando los grupos con resultado positivo y negativo para infección por VPH; mientras que, para el análisis inferencial se empleará la prueba chi cuadrado considerando un nivel de significancia de 0,05, debido a la naturaleza categórica de ambas variables. Para determinar la fuerza de asociación se calcularán los Odds Ratio o Razón de probabilidades de los factores que tengan un valor significativo.

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022
	UPNW-EES-FOR-067	REVISIÓN: 01	

Palabras clave: Cáncer de cuello uterino, Factores, Virus de papiloma humano.

9. Planteamiento y Formulación del Problema

9.1 Planteamiento del problema:

El cáncer de cuello uterino es una neoplasia cuya causa predominante es el virus del papiloma humano (VPH), y representa un importante problema de salud en el Perú, debido a sus altas tasas de morbilidad y mortalidad. Por ello, el conocimiento de la prevalencia del VPH, así como los principales factores que se asocian al desarrollo de esta infección, es crucial para el desarrollo de intervenciones de salud pública específica y efectivas.¹

La distribución del VPH alrededor del mundo lo han convertido en un problema de salud pública de gran magnitud, con un gran impacto en la salud de la población por su estrecha relación con la aparición de diversos tipos de neoplasias, siendo el cáncer de cuello uterino el más frecuente y el de mayor gravedad. Además, representa en los países un alto costo sanitario, ya que obliga a los sistemas de salud a costear anualmente las estrategias de prevención, entre insumos, recursos tecnológicos y recursos humanos².

A nivel mundial existen notorias diferencias entre los estudios publicados de manera reciente. En Turquía, sólo se encontró un 6,7% de casos positivos para el ADN del VPH, de los cuales el 66% de ellos pertenecía al grupo de alto riesgo, siendo esto más frecuente entre las mujeres cuya edad está entre los 30 y 39 años.³ Por otra parte, en China se reportó una tasa promedio de infección por VPH del 16%, siendo este porcentaje mayor cuando se trataba de pacientes atendidos de manera ambulatoria, y también entre las mujeres con menor edad, en las que podía alcanzar un porcentaje mayor del 40%.⁴ En el caso de la India, se ha encontrado una prevalencia general de la infección por VPH del 37,3%, con una mayor positividad para esta infección entre las mujeres con lesiones pre malignas, intraepiteliales y malignas invasivas del cuello uterino, las que tienen mayor edad y un mayor número de hijos.⁵

Respecto a América Latina y el Caribe, los hallazgos varían de acuerdo a las características y el tamaño de la población estudiada. En un estudio realizado en México se encontró que la infección del VPH sólo se encontraba en el 26% de las mujeres sanas, siendo estas heterogéneas, especialmente para el caso de genotipos de bajo riesgo, y en los casos que presentan lesiones precursoras de neoplasia cervical⁶. En Argentina, un estudio reciente reportó que la prevalencia del VPH entre la población femenina es del 30,7%, de los cuales poco más del 70% pertenecen a los genotipos de alto riesgo, siendo esto más frecuente entre las mujeres más jóvenes y las que tenían mayor número de parejas sexuales.⁷ Por otro lado, un estudio realizado en Chile con trabajadoras sexuales encontró en ellas una prevalencia de infección por VPH del 45%, de los cuales el 63% pertenecía a tipos de alto riesgo y un 43% presentaba infección con múltiples genotipos, lo cual evidencia la alta vulnerabilidad que tiene este grupo poblacional para sufrir esta enfermedad.⁸

A nivel nacional, un estudio realizado en Ucayali entre mujeres con diagnóstico positivo para la inspección visual con ácido acético reportó la presencia de infección por VPH en el 61% de casos, con una mayor frecuencia de los genotipos de alto riesgo 16 y 18, y destacando como factores de riesgo la edad de la primera relación sexual, el número de gestaciones y el antecedente de una infección de transmisión sexual.⁹ Por otra parte, un estudio realizado en Arequipa en mujeres con atipia de células escamosas de incierto significado, reportó un 41,8% de casos positivos para el VPH, existiendo un 33,9% para los genotipos de alto riesgo, grupo en el cual el principal factor asociado lo representa el tener una edad mayor de 30 años.¹⁰

La situación presentada evidencia la necesidad de realizar estudios específicos para la realidad de cada establecimiento de salud, ya que los factores que se encuentran en la población varían notoriamente aún dentro de una misma región, y puede afectar el cumplimiento de las metas de las estrategias implementadas. Por ejemplo, en el Centro de

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO: UPNW-EES-FOR-067	VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022

Salud Conde la Vega Baja acuden con relativa frecuencia mujeres para atención de ITS y Papanicolaou, pero pocas se realizan pruebas de detección del VPH, a pesar de la gratuidad de la misma, encontrándose en el grupo de mujeres con resultado positivo una oportunidad para realizar investigaciones que permitan comprender mejor los factores que han favorecido la presencia de dicha infección. Por ello, en base al panorama descrito, se formuló la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuáles son los factores asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023?

9.2 Formulación del problema:

Problema general

¿Cuáles son los factores asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023?

Problemas específicos

¿Cuáles son los factores sociodemográficos están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023?

¿Cuáles son los factores obstétricos están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023?

¿Cuáles son los factores personales están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023?

10. Justificación:

La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes a nivel mundial, y está asociada con el desarrollo de cáncer cervical, que es una de las principales causas de mortalidad en mujeres. A nivel teórico, la investigación es fundamental porque contribuye a una mejor comprensión de los factores de riesgo asociados con la infección por VPH en mujeres en edad fértil. Este conocimiento es crucial para desarrollar modelos teóricos que expliquen la dinámica de la transmisión del virus, la respuesta del sistema inmunológico y la progresión de la infección hacia condiciones más graves como el cáncer. Además, la investigación puede aportar al cuerpo de conocimiento existente, apoyando la creación de teorías más integrales sobre la prevención y control de la infección por VPH.

La justificación metodológica se basa en la necesidad de utilizar enfoques rigurosos y validados para identificar y analizar los factores asociados a la infección por VPH. Este estudio empleará un diseño metodológico apropiado que permitirá no solo identificar los factores de riesgo, sino también establecer posibles correlaciones y relaciones causales. El uso de técnicas estadísticas avanzadas y el análisis de datos provenientes de muestras representativas garantizarán la validez y confiabilidad de los hallazgos, contribuyendo así a la generación de evidencias sólidas que pueden ser utilizadas en futuras investigaciones y en la formulación de políticas de salud pública.

La relevancia práctica de esta investigación radica en el potencial que tiene la investigación para mejorar las estrategias de salud pública orientadas a la prevención y manejo del VPH en mujeres en edad fértil. Al identificar los factores asociados a la infección, se pueden diseñar intervenciones más efectivas y focalizadas para reducir la prevalencia del VPH y sus complicaciones. Además, los resultados podrían servir para sensibilizar y educar a la población femenina sobre la importancia de las medidas preventivas, como la vacunación y la realización de pruebas de detección temprana, e incluso, la realización de talleres o escuela para padres y charlas en los colegios con el fin de abordar el problema desde la etapa escolar,

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022
	UPNW-EES-FOR-067	REVISIÓN: 01	

que es donde se inicia la prevención de la infección con VPH. Esto puede tener un impacto directo en la reducción de la carga de la enfermedad y en la mejora de la calidad de vida de las mujeres

11. Objetivo general y específicos

11.1 General:

Analizar los factores asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

11.2 Específicos:

Identificar los factores sociodemográficos asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

Identificar los factores obstétricos asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

Identificar los factores personales asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

12. Marco teórico

12.1 Antecedentes

Antecedentes internacionales

Daza D, Mendivelso L, Acero J., en el año 2024, en Colombia, realizaron un estudio que tuvo como objetivo investigar la relación entre factores sociodemográficos y clínicos y la infección por VPH en mujeres de 18 a 65 años en el Hospital Militar Central de Bogotá. Dicho estudio fue de tipo observacional transversal y contó con 100 mujeres que se sometieron a la prueba de ADN-VPH entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Los datos se recolectaron mediante una encuesta semiestructurada y se analizaron con un modelo de regresión logística usando SPSS. Los resultados mostraron una prevalencia de VPH del 17%. La vasectomía en la pareja fue el único factor asociado en el análisis bivariado, posiblemente debido al no uso de preservativos. El análisis multivariado indicó que el número de compañeros sexuales y la ausencia de métodos anticonceptivos estaban significativamente asociados con la infección. Se concluye que es crucial sensibilizar sobre el riesgo de VPH, resaltando la importancia de métodos anticonceptivos y reducir el número de compañeros sexuales.

Morales G, et al. En el año 2023 en México, plantearon como objetivo establecer la relación entre factores de riesgo y la infección por VPH en mujeres de una ciudad mexicana, mediante un estudio de casos y controles pareado por edad. El estudio incluyó a 33 mujeres con VPH y 66 sin VPH (edad media = $41,8 \pm 7,9$ años). Se utilizaron regresiones logísticas condicionales para analizar diferencias entre los grupos y se ajustó el consumo de antioxidantes por energía total. Los modelos de regresión logística multivariada revelaron que un mayor consumo de licopeno (OR = 0,96) y una mayor capacidad antioxidante total plasmática (CATp) (OR = 0,05) estaban asociados con un menor riesgo de VPH. En contraste, los múltiples embarazos y tener una conducta sexual activa aumentaron el riesgo. Se concluye que promover la educación sexual y el consumo de antioxidantes podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer cervical en esta población.

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022
	UPNW-EES-FOR-067	REVISIÓN: 01	

Salazar Z, Heredia J, Zhingre A, Cárdenas F., en el año 2022 en Ecuador, realizaron una investigación que tuvo como objetivo determinar los factores asociados a las infecciones por VPH de alto riesgo (AR) en mujeres de 21 a 65 años, para lo cual se realizó un estudio analítico de corte transversal en 109 pacientes, utilizando registros clínicos de un proyecto epidemiológico. Los resultados obtenidos evidencian que, de las participantes, el 28,4% (31 casos) presentaron VPH de alto riesgo, siendo los genotipos de mayor frecuencia el 39 y el 31, con porcentajes de 11,0% y 8,3%, respectivamente. Además, aunque el inicio de la vida sexual antes de los 20 años (OR = 1,2) y tener dos o más parejas sexuales (OR = 1,7) se consideraron factores de riesgo, no mostraron significancia estadística. Se concluye que ambos factores están asociados, pero sin relevancia estadística.

Cuesta L, Torres H, Quintero M, Borges R, Cruz J., en el año 2020, en Venezuela, desarrollaron un estudio con el objetivo de relacionar los factores de riesgo, la presencia de lesiones intraepiteliales y la infección por VPH en mujeres de Santos Marquina, Mérida, Venezuela. Se llevó a cabo un estudio transversal con 1,639 participantes que se sometieron a citologías cervicouterinas, colposcopias, pruebas de detección y tipificación de VPH mediante PCR, y encuestas. Se encontró que el 31,8% de las mujeres tenían infección por VPH y el 5,6% presentó anomalías en la citología. Entre los casos tipificados, el 42% tenía tipos de bajo riesgo y el 55% tipos de alto riesgo. Las citologías anormales fueron más comunes con VPH de alto riesgo (13,4%) en comparación con los de bajo riesgo (6,4%). Un mayor número de compañeros sexuales y antecedentes de gestación se asociaron significativamente con citologías anormales, mientras que el número de compañeros sexuales, vivir en áreas rurales y ser menor de 35 años se asociaron con la infección por VPH. Se concluye que el tipo de VPH y diversos factores de riesgo influyen en las lesiones cervicouterinas.

Antecedentes nacionales

Quesada E, Revollo P, en el año 2023, en Lima, realizaron una investigación para cuantificar la prevalencia de los distintos genotipos de VPH de alto riesgo, a través de un estudio transversal analítico que contó con una muestra de 128 historias clínicas de pacientes atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Los resultados destacan los principales factores de riesgo asociados a la infección por VPH corresponden al lugar de procedencia, la afiliación a un sistema de seguros de salud y la existencia de comorbilidades. Se concluye que hay factores sociodemográficos y clínicos a considerar en la prevención de la infección por VPH.

Florián A, et al, en el año 2023, en la selva peruana, realizaron un estudio para determinar cómo se distribuyen los tipos de VPH en mujeres con resultado positivo para lesión intraepitelial con la prueba de inspección visual con ácido acético, a través de un estudio analítico que contó con una muestra de 56 mujeres que cumplían los criterios de selección. Los resultados indican que existe una prevalencia de infección por VPH del 61%, y los factores asociados variaban según el genotipo encontrado, destacándose la edad de la mujer, la edad de inicio de relaciones sexuales y el antecedente de infección de transmisión sexual (ITS). Se concluye que los factores que se asocian a la infección por VPH varían según el genotipo de VPH predominante en la población de estudio.

Zavaleta V, el año 2022, en Trujillo, realizaron una pesquisa con el objetivo de identificar los factores asociados a la infección por VPH en mujeres atendidas en un hospital de la región, a



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

través de un estudio analítico de casos y controles, en el cual se incluyó una muestra conformada por 48 casos con la infección y 120 controles sin la infección. Los resultados evidencian que los principales factores de riesgo asociados corresponden a tener tres o más parejas sexuales con OR 2.23, presentar una ITS previa con OR 2.28, mientras que, como factores protectores se reportaron a la educación superior con OR 0.26, y el uso de profilácticos en los últimos meses con OR 0.46. Se concluye que existen factores obstétricos asociados a la infección por VPH que pueden abordarse en estrategias sanitarias dirigidas por el obstetra.

Iglesias S, Serquén L, el año 2020, en Lambayeque, realizaron una pesquisa con el objetivo de determinar los factores asociados a la infección por VPH en mujeres que presentan citología desconocida atendidas en un hospital regional, a través de un estudio descriptivo transversal en el que se seleccionaron 186 muestras para el estudio. Los resultados indican que la frecuencia con que se encuentra el VPH en la muestra seleccionada es del 29,9%, y no se reportó asociación significativa para los factores analizados, como la edad, el inicio de relaciones sexuales, el número de parejas coitales, la paridad, la existencia de lesión en el cuello uterino, el uso de hormonas anticonceptivas, los antecedentes de infección de transmisión sexual, el uso de preservativo y el hábito de fumar.

12.2 Bases teóricas

Infección por VPH

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es considerada como la infección de transmisión sexual más frecuente y una de las mayores causas de morbilidad en la población. Se trata de un conjunto de virus de ADN pertenecientes a la familia Papillomaviridae, responsables de aproximadamente 4,5% de todos los cánceres en humanos, entre ellos los tumores del cuello uterino, la vagina, el pene, el ano, la vulva, la laringe, la orofaringe y la cavidad oral.

Clasificación del VPH

Hasta el momento se han identificado más de 120 tipos de VPH y la infección persistente con genotipos de alto riesgo está asociada con el desarrollo de lesiones intraepiteliales cervicales que pueden progresar a cáncer de cuello uterino. Según la frecuencia de detección en cáncer cervical, los genotipos de VPH se dividen en dos categorías: tipos de bajo riesgo como los VPH 6, 11, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 y 8118, y tipos de alto riesgo, dentro de los cuales se encuentran los tipos VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 clasificados como carcinógenos del Grupo I en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, el VPH 68 que se clasifica como un posible carcinógeno²¹. Dentro de este grupo de alto riesgo, los tipos más frecuentemente asociados con el cáncer son el VPH 16 y 18, responsables de alrededor del 71% de los cánceres de cuello uterino y de casi todos los cánceres relacionados con el VPH en los hombres.

Las infecciones por los tipos de VPH cancerígenos son muy comunes, diversos estudios sugieren que alrededor del 75% de las personas sexualmente activas se infectarán con alguno de estos en algún punto de su vida; sin embargo, son eliminadas por el sistema inmunológico cerca del 80% de estas infecciones, en un plazo de tres años y solo el 3% evoluciona a lesiones precancerosas o cáncer cervical en un periodo de siete años.



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

Infección por VPH y cáncer de cuello uterino

La evolución del VPH hacia el cáncer de cuello uterino sigue un proceso progresivo. Inicialmente, cuando este tipo de virus infecta las células diana, los oncogenes virales E6 y E7 desactivan los genes supresores de tumores p53 y pRb. Esta inactivación provoca la resistencia a la apoptosis y una proliferación celular descontrolada. Si bien las infecciones por los tipos de VPH cancerígenos son muy comunes²⁰, diversos estudios sugieren que alrededor del 75% de las personas sexualmente activas se infectarán con alguno de estos en algún punto de su vida; sin embargo, son eliminadas por el sistema inmunológico cerca del 80% de estas infecciones, en un plazo de tres años y solo el 3% evoluciona a lesiones precancerosas o cáncer cervical en un periodo de siete años. En este sentido, si la infección por VPH se vuelve persistente, una parte de los pacientes podría desarrollar cáncer de cuello uterino a través de varios pasos clave.

En el caso de una infección persistente, el genoma del VPH se integra en el ADN del huésped humano. Esta integración resulta en la expresión continua de los oncogenes E6 y E7, lo que perpetúa la desactivación de p53 y pRb. Además, la integración del VPH genera alteraciones genéticas adicionales, como la amplificación de oncogenes, reordenamientos del ADN e inestabilidad cromosómica en el área del sitio de integración. Con el tiempo, la acumulación de estas alteraciones genéticas en las células infectadas por VPH provoca una transformación maligna, que finalmente lleva al desarrollo del cáncer de cuello uterino.

Diagnóstico de la infección del VPH

La identificación de lesiones cervicales, ya sean preinvasivas o cancerosas, es posible a través del cribado poblacional. Este proceso tiene como objetivo detectar lesiones precancerosas para así poder tratarlas y evitar que evolucionen a carcinoma. De acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF), se aconseja que las mujeres se realicen una citología cervical o llamada prueba de Papanicolaou cada 3 años. Para las mujeres de entre 30 y 65 años, existen tres opciones de detección: realizar el Papanicolaou cada 3 años, optar por una prueba de VPH de alto riesgo cada 5 años, o una combinación de ambas pruebas, igualmente, cada 5 años.

Cabe señalar que, actualmente, la Sociedad Estadounidense del Cáncer sugiere como método principal de detección desde los 25 años, la prueba del VPH. Asimismo, dado que hay un largo período de latencia entre el diagnóstico y la infección cervical por VPH, la incidencia del carcinoma alcanza su punto máximo alrededor de los 40 años. Esto subraya la importancia de realizar pruebas de detección para identificar cambios cervicales relacionados con el VPH entre los 30 y 40 años.

Manejo y prevención de la infección por VPH

Respecto al manejo de la infección por el VPH, esta va a depender del estadio de la enfermedad. Las verrugas anogenitales se manejan con terapias locales; no obstante, es crucial un seguimiento regular debido al riesgo de que reaparezcan. Por otro lado, para las lesiones de NIC, el enfoque debe ser específico. De esta manera y dado que las lesiones NIC 1 tienen una alta probabilidad de regresión, es preferible optar por un seguimiento en lugar de un tratamiento invasivo. En casos de pacientes con lesiones de NIC 2 y 3 deben recibir tratamiento mediante procedimientos de escisión electroquirúrgica con asa, conización o crioterapia. Asimismo, para los carcinomas invasivos se tratar en base a los principios oncológicos, y puede involucrar cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias dirigidas.

La estrategia de la OMS dirigida a erradicar el cáncer de cuello uterino a nivel mundial plantea la vacunación contra el VPH en el 90% de las niñas menores de 15 años y la realización de pruebas de detección al 70% de las mujeres a través de una prueba de alta precisión antes



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

de los 35 años y otra antes de los 45, así como el tratamiento del 90% de las mujeres con enfermedades cervicales²⁵. Dicha organización emitió, en el 2021, directrices que recomiendan el uso de pruebas de ADN del VPH como método principal de tamizaje, indicando que estas pruebas se realicen con muestras recogidas por profesionales de la salud o por las propias mujeres con la finalidad de detectar y tratar la enfermedad en etapas tempranas, lo que ayuda a prevenir rápidamente las lesiones precancerosas en las mujeres y el cáncer de cuello uterino avanzado.

Factores asociados a la infección por VPH

Se han documentado detalladamente los factores de riesgo relacionados con la infección por VPH. Entre los cuales se encuentran la edad, los comportamientos sexuales, el tipo de VPH y el alto número de nacimientos como los más comprobados.

Frecuentemente son divididos en sociodemográficos, obstétricos y personales.

Factores sociodemográficos

Entre los factores sociodemográficos encontramos los siguientes:

- Edad, asociada a una mayor vulnerabilidad del epitelio cervical durante la etapa final de la adolescencia hasta los 30 años, lo que aumenta la susceptibilidad a contraer la infección²⁸.
- Grado de instrucción, vinculado con el desconocimiento sobre la enfermedad, ya que muestra una prevalencia del 65% en la adquisición de la enfermedad en mujeres que cuentan con un grado de instrucción en educación básica y media.
- Nivel socioeconómico, especialmente pertenecer a un estrato bajo, está relacionado con la presencia del VPH, ya que las mujeres con ingresos económicos limitados no suelen tener acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo las pruebas de Papanicolaou, lo que implica que es menos probable que se realicen exámenes de detección o reciban tratamiento oportuno.
- Estado civil, a pesar de que algunos estudios no han encontrado una asociación significativa con este factor, una investigación en México con un grupo de 110 mujeres reveló que el 50,9% de las solteras presentaron resultados positivos para el VPH tipo 1628.

Factores obstétricos

Por el lado de los factores obstétricos se destacan:

- Inicio de las relaciones sexuales, particularmente antes de los 20 años, ya que entre los 15 y 19 años el epitelio cervical es más vulnerable a infecciones y alteraciones causadas por agentes transmitidos por contacto sexual.
- Paridad, siendo las mujeres con más de tres embarazos a término las de mayor probabilidad de contraer el VPH, ya que su sistema inmunológico se debilita, lo que las hace más susceptibles a la infección.
- Antecedentes de ITS, al experimentar frecuentemente estas infecciones, no solo se aumenta la probabilidad de desarrollar VPH, sino que, al no recibir tratamiento, se favorece la formación de lesiones lo cual provoca daño en las células del cuello uterino y, con el tiempo, puede llevar al desarrollo de cáncer cervical.
- Número de parejas sexuales, según la evidencia reportada, la transmisión del VPH, en especial de los virus que presentan alto riesgo, se da mayormente en mujeres que han tenido un número de cinco a más parejas sexuales. Esto es aún más grave cuando se trata de mujeres más jóvenes, en comparación con aquellas que tienen pareja estable.



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

Factores personales

Para finalizar, se encuentran los factores personales, entre los cuales están:

- a) Hábito de fumar, debido a que el humo del tabaco tiene propiedades carcinogénicas, atribuibles a la nicotina en la sangre, que se detectan en el cuello uterino y el moco cervical, además, existen evidencias de que 32% de las mujeres infectadas con VPH que fuman desarrollan células cancerosas.
- b) Uso de anticonceptivos hormonales, puesto que tienen un riesgo tres veces mayor de desarrollar cáncer de cuello uterino aquellas mujeres que usan anticonceptivos orales por más de cinco años y en aquellas que lo usan más de 10 años, el riesgo se cuadruplica.
- c) Uso de preservativos, este factor, por el contrario, contribuye a prevenir la transmisión del VPH y de otras infecciones de transmisión sexual, siempre y cuando se utilice de manera constante en cada relación sexual.

Definiciones:

Factores de riesgo

Eventos o circunstancias que predisponen la aparición de la infección con el VPH, identificado en las historias clínicas. Comprende tres dimensiones:

Factores sociodemográficos: corresponde a aquellas características sociales y demográficas de una población o individuo que pueden influir en su comportamiento, salud, y calidad de vida, los cuales incluyen:

Edad de la paciente:

Definición operacional: Edad en años cumplidos al momento de la encuesta.

Medición: Variable categórica (de 20 a 29 años, y de 30 a 40 años).

Estado civil:

Definición operacional: Estado marital actual de la participante.

Medición: Variable categórica (Soltera, Casada, Conviviente, Divorciada, otro).

Grado de instrucción:

Definición operacional: Nivel máximo de educación formal alcanzado por la participante.

Medición: Variable categórica (Sin educación formal, Primaria, Secundaria, Técnica, Universitaria).

Procedencia:

Definición operacional: Lugar de residencia habitual de la participante.

Medición: Variable categórica (Urbana, Rural).

Tipo de seguro de salud:

Definición operacional: Tipo de cobertura de salud que tiene la participante.

Medición: Variable categórica (Público, Privado, Ninguno).

Factores obstétricos: corresponde a aquellas características que se relacionan con el embarazo, el parto, y la salud reproductiva de una mujer, e incluyen:

Edad de inicio de relaciones sexuales:

Definición operacional: Edad en la que la participante tuvo su primera relación sexual.

Medición: Variable categórica (menos de 14 años, de 14 a 18 años, más de 18 años).

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022
	UPNW-EES-FOR-067	REVISIÓN: 01	

Paridad:

Definición operacional: Número de partos que ha tenido la participante.

Medición: Variable categórica (ningún parto, sólo un parto, más de un parto).

Número de parejas sexuales:

Definición operacional: Número total de parejas sexuales que ha tenido la participante a lo largo de su vida.

Medición: Variable categórica (sólo una, sólo dos, sólo tres, más de tres).

Antecedente de Infección de transmisión sexual:

Definición operacional: Historia previa de alguna infección de transmisión sexual confirmada por diagnóstico médico.

Medición: Variable categórica (Sí, No).

Factores personales: corresponde a aquellas características relacionadas con el comportamiento o conducta propia de la persona, e incluyen:

Hábito de fumar:

Definición operacional: Consumo regular de cigarrillos por la participante.

Medición: Variable categórica (Fumadora frecuente, Fumadora ocasional, Nunca ha fumado).

Uso de anticonceptivo hormonal:

Definición operacional: Uso actual o pasado de métodos anticonceptivos hormonales por la participante.

Medición: Variable categórica (Sí, No).

Uso de preservativo:

Definición operacional: Frecuencia del uso de preservativos durante las relaciones sexuales.

Medición: Variable categórica (Siempre, A veces, Nunca).

Infección por VPH: Resultado positivo para infección con el virus del VPH, reportado en las historias clínicas.

13. Hipótesis:

13.1 Hipótesis general:

H1: Los factores sociodemográficos, personales y obstétricos están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

H0: Los factores sociodemográficos, personales y obstétricos no están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

13.2 Hipótesis específicas:

H1: Los factores sociodemográficos están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

- H0: Los factores sociodemográficos no están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.
- H2: Los factores obstétricos están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.
- H0: Los factores obstétricos no están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.
- H3: Los factores personales están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.
- H0: Los factores personales no están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, Lima-2023.

14. Materiales y métodos:

14.1 Diseño de la investigación

El estudio presentará un diseño observacional, caracterizado porque el investigador no interviene ni manipula las variables durante el proceso, y dentro de dicho diseño, se encuentra en el denominado diseño de casos y controles, en el que se compararán dos grupos, uno con resultado positivo para la prueba molecular de VPH y otro con resultado negativo.

14.2 Tipo de estudio

El estudio es de tipo retrospectivo, ya que los instrumentos de recojo de información serán diseñados de manera posterior al registro de los datos en una fuente primaria, la cual, para fines del estudio serán las historias clínicas.

14.3 Población

La población estará integrada por las historias clínicas de las mujeres que se han realizado una prueba molecular de VPH en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja entre los meses de enero a diciembre del 2023, el cual, según reportes estadísticos del nosocomio, consta de 190 mujeres.

14.4 Tamaño de muestra

La muestra estará formada por un grupo de casos con resultado positivo de VPH en la prueba molecular y un grupo de controles con resultado negativo para dicha prueba, y con un tamaño proporcional entre ambas. De acuerdo con la oficina de estadística del centro de salud, el número de resultados positivos fue de 28 usuarias. Se considerará una proporción de 3 a 1 para calcular el tamaño del grupo de controles, obteniendo así un número de 84. Entre ambos, el tamaño de muestra total será de 112 mujeres.

$$n = \frac{190 * (1,96^2 * 0,5 * 0,5)}{e^2(189) + (1,96^2 * 0,5 * 0,5)} = 128$$

Criterios de inclusión para el grupo de casos

- Historias clínicas de mujeres que se han realizado una prueba molecular de VPH en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja y presentaron un resultado positivo.

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022
	UPNW-EES-FOR-067	REVISIÓN: 01	

- La prueba debió ser realizada dentro del periodo enero-diciembre del año 2023.

Criterios de inclusión para el grupo de controles

- Historias clínicas de mujeres que se han realizado una prueba molecular de VPH en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja y presentaron un resultado negativo.
- La prueba debió ser realizada dentro del periodo enero-diciembre del año 2023.

Criterios de exclusión

- Presentar información incompleta en su historia clínica.

El muestreo que se aplicará en el estudio corresponde a un censal para el grupo de los casos y aleatorio simple para el grupo de los controles.

14.5 Técnica e instrumento de recolección de datos

Se empleará una revisión documental, técnica que consiste en la obtención de información a partir de una fuente primaria, para este caso las historias clínicas, los cuales se trasladan a un registro que ha sido previamente elaborado por la autora para su posterior análisis.

El instrumento es una ficha de recolección conformada por 13 ítems, y dividido en dos partes. La primera parte corresponde a los factores asociados, los cuales están agrupados en tres secciones: factores demográficos con 5 ítems, factores obstétricos con 4 ítems y factores personales con 3 ítems. La segunda parte corresponde a la infección por VPH, y contiene sólo un ítem en el que se indicará el resultado de la prueba realizada a la participante, sea positivo o negativo. Los ítems del instrumento son cerrados, con alternativa múltiple, y algunas son dicotómicas, y sus respuestas serán codificadas antes de su traslado al programa estadístico.

La validación del instrumento se realizará a través de un juicio de expertos en el que participarán tres obstetras con grado de maestría, quienes valorarán cada uno de los ítems en base a los criterios de claridad, relevancia y pertinencia, aceptándose sólo aquellos ítems que presenten una respuesta a favor unánime. (ver anexo 3)

La confiabilidad se determinará a través de una prueba piloto en la que se seleccionarán 20 mujeres a las que se haya realizado la prueba molecular de VPH en el establecimiento de salud donde se realizará el estudio, aplicando la técnica del test-retest. Para ello se procederá a recoger la información dos veces, con un tiempo de separación de tres días, y luego se compararán estadísticamente las coincidencias entre los registros de ambos momentos, considerando como confiabilidad aceptable un valor mayor o igual a 0,7.

14.5 Plan de procesamiento y análisis de datos

El proyecto, luego de su aprobación por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Norbert Wiener, será entregado al médico jefe del Centro de Salud Conde de la Vega Baja junto a una solicitud de autorización para realizar el estudio en dicho establecimiento. Con dicha autorización se procederá a coordinar con el área de archivos de historias clínicas para acceder a la información correspondiente a las usuarias que se han realizado una prueba molecular de VPH a lo largo del año 2023. Toda la información necesaria para la investigación será recogida de cada historia clínica mediante la ficha de recolección elaborada por la autora del estudio.



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

Los datos recogidos de las fichas de recolección serán trasladados en una base de datos del paquete estadístico SPSS versión 25 para su análisis, el cual se dividirá en una fase descriptiva y otra inferencial. En el análisis descriptivo se presentarán tablas de frecuencias y porcentajes de las variables consideradas en la investigación, comparando los grupos con resultado positivo y negativo para infección por VPH; mientras que, para el análisis inferencial se empleará la prueba chi cuadrado considerando un nivel de significancia de 0,05, debido a la naturaleza categórica de ambas variables. Para determinar la fuerza de asociación se calcularán los Odds Ratio o Razón de probabilidades de los factores que tengan un valor significativo.

15. Aspectos éticos

Por tratarse de un estudio retrospectivo, no se requerirá redactar un consentimiento informado para los participantes. Sin embargo, a fin de respetar los principios bioéticos, la investigadora se comprometerá a respetar el anonimato y confidencialidad de la información que se recolecte, así como el hecho de que dichos datos no se emplearán para fines ajenos al estudio.

16. Recursos y presupuesto

	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Investigador	-	-	-
Digitadores	200.00	200.00	200.00
Estadístico	300.00	300.00	300.00
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS (BIENES)			
Hojas bond	50.00	2 millares	100.00
Lapiceros	10.00	1 docena	10.00
USB (8 Gb)	40.00	1 unidad	40.00
SERVICIOS			
Internet	70.00	2 meses	140.00
Fotocopias	0.10	400	40.00
Refrigerios y movilidad	20.00	21 días	420.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O IMPREVISTOS			
Imprevistos			250.00
TOTAL			1500.00



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

17. Cronograma de Actividades

N	Actividad	2024								2025			
		May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
1	Elección del tema	X											
2	Búsqueda bibliográfica	X											
3	Redacción del proyecto	X	X	X	X	X	X	X					
4	Elaboración de la ficha de recolección					X	X	X					
5	Coordinación con el establecimiento								X				
6	Recolección de datos								X				
7	Sistematización de la información									X			
8	Análisis estadístico									X			
9	Corrección de estilo										X		
10	Redacción del informe final											X	
11	Sustentación												X

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO: UPNW-EES-FOR-067	VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022

18. Anexos: Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VI: Factores de riesgo - Socio demográficos - Obstétricos - Personales VD: Infección por VPH	Enfoque: Cuantitativo.
¿Cuáles son los factores asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023?	Analizar los factores asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.	Los factores sociodemográficos, personales y obstétricos están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.		Diseño: No experimental
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS		Nivel: Correlacional
Identificar si los factores sociodemográficos están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.	Identificar si los factores sociodemográficos están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.	Los factores sociodemográficos están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.		Población: 190 mujeres que se han realizado una prueba molecular de VPH en el C.S. Conde de la Vega Baja en el año 2023.
¿Los factores obstétricos están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023?	Identificar si los factores obstétricos están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.	Los factores obstétricos están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.		Muestra: 128 mujeres.
Determinar si los factores personales están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.	Determinar si los factores personales están asociados a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.	Los factores personales están asociados significativamente a la infección por VPH en mujeres de 30 a 49 años atendidas en el Centro De Salud Conde de la Vega Baja, 2023.		Técnica: Revisión documental.
				Instrumento: Ficha de recolección.

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO: UPNW-EES-FOR-067	VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022

Ficha de recolección de datos de historias clínicas de mujeres que se realizaron prueba de VPH en el C.S. Conde de la Vega Baja 2023

Código:

Factores de riesgo:

I. Factores sociodemográficos

1. Edad:
☐ De 30 a 39 años
☐ De 40 a 49 años
2. Estado civil:
☐ Soltera
☐ Casada
☐ Conviviente
☐ Divorciada
☐ Otro Especifique:
3. Grado de instrucción:
☐ Sin educación formal
☐ Primaria
☐ Secundaria
☐ Técnico
☐ Superior
4. Procedencia
☐ Zona rural
☐ Zona urbana
5. Tipo de seguro
☐ SIS
☐ Essalud
☐ Privado

II. Factores obstétricos

6. Edad de inicio de relaciones sexuales
☐ Menos de 14 años
☐ De 14 a 18 años
☐ Más de 18 años
7. Paridad
☐ Ninguno
☐ Sólo uno
☐ Más de uno
8. Número de parejas sexuales
☐ Sólo una
☐ Sólo dos



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

- ☐ Sólo tres
☐ Más de tres

9. Antecedente de infección de transmisión sexual

- ☐ No
☐ Sí

III. Factores personales

10. Hábito de fumar

- ☐ Fumadora frecuente, todos los días
☐ Fumadora ocasional, algunos días

11. Uso de anticonceptivo hormonal

- ☐ Sí, píldoras
☐ Sí, inyectables
☐ No

12. Uso de preservativo

- ☐ Siempre
☐ A veces
☐ Nunca

Infección por VPH

- ☐ Positivo
☐ Negativo

19. Referencias bibliográficas:

1. Satapathy P, Khatib MN, Neyazi A, Qanawezi L, Said S, Gaidhane S, et al. Prevalence of human papilloma virus among cervical cancer patients in India: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2024;103(31): e38827. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/md.00000000000038827>
2. Núñez J. Epidemiología del virus del papiloma humano. *Invest. clín.* 2022; 63 (2): 170-184. Disponible en: <https://doi.org/10.54817/ic.v63n2a07>
3. Aydogdu G. Distribución de la prevalencia del virus del papiloma humano, genotipo y resultados de la prueba de PAP en mujeres del sureste de Turquía. *Cir Cir.* 2023; 91(3): 9760. Disponible en: <https://doi.org/10.24875/CIRU.22000400>
4. Hu JP, Wang JL, Li Y, Feng Y, Tian CQ, Zhang GH, et al. Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus infection among 66000 women from 2014 to 2023 in the plateau region of Southwest China. *Virol J.* 2024;21(1):176. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12985-024-02447-2>
5. Pankaj S, Rani J, Kumari P, Abhilashi K, Choudhary V, Kumari S, et al. Prevalence, risk factors and genotype distribution of human papillomavirus infection among women with and without invasive cervical cancer: Findings from a hospital-based study in Bihar, India. *Natl Med J India.* 2024; 37(1):13-7. Disponible en: https://doi.org/10.25259/nmji_634_21



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

6. González-Yebra B, Mojica-Larrea M, Alonso R, González AL, Romero-Morelos P, Taniguchi-Ponciano K, et al. HPV infection profile in cervical lesions. Gac México. 2022;158(4):9622. Disponible en: <https://doi.org/10.24875/gmm.m22000679>
7. Jordá GB, Ramos JM, Mosmann J, Lopez ML, Wegert A, Cuffini C. Prevalencia del virus papiloma humano y factores de riesgo asociados en mujeres afiliadas al seguro de salud estatal en Posadas, Misiones (Argentina). Rev Chil Infectol. 2020;37(2):111-6. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/s0716-10182020000200111>
8. Hott-Schulz K, Ramírez-Villalobos E, Ortega-Peña M, Santander-Cabello E, Fernández-Moraga J, Zemelman-Decarli V, et al. Prevalencia y genotipificación de virus papiloma humano vaginal y cervical en trabajadoras sexuales de un centro de salud sexual en la zona Norte de Santiago, Chile. Rev Chil Infectol. 2022;39(2):117-25. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182022000200117>
9. Florian-Cáceres A, Iglesias-Osores S, Marino-Panduro L, Atoche GB, Rafael-Heredia A. Genotipos de papiloma virus en mujeres de la selva peruana con inspección visual con ácido acético positivo. Rev Obstet Ginecol Venezuela. 2023;83(1):28-34. Disponible en: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ogv/article/view/26368/144814492342
10. Medina G. Prevalencia de infección por genotipos del virus del papiloma humano en mujeres con atipia de células escamosas de significado incierto. Ginecol Obstet México. 2020;88(7):437-41. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/gom/v88n7/0300-9041-gom-88-07-437.pdf>
11. Daza D, Mendivelso L, Acero J. Factores asociados con infección de VPH en una población de mujeres de 18 a 65 años en un hospital de tercer nivel de Bogotá, estudio de corte transversal [Internet] [Tesis de pregrado]. [Colombia]: Universidad del Rosario; 2024. Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co/items/183363e2-2a01-4c80-a05d-f905dfcb94c8>
12. Morales GG, Bravo M, Olivas KM, Esparza J, Valenzuela M, Olivas OM, et al. Associated factors with human papillomavirus infection in adult women from northwest Mexico. Biotechnia. 2022;25(1):133-9. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/biotechnia/v25n1/1665-1456-biotechnia-25-01-133.pdf>
13. Salazar Torres ZK, Heredia Cortez JM, Zhingre Suárez AE, Cárdenas Heredia FR. Virus del papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de Ecuador. Rev Vive. 2022;5(15):671-8. Disponible en: <https://doi.org/10.33996/revistavive.v5i15.178>
14. Cuesta L, Torres HA, Quintero M, Borges R, Cruz JF. Asociación entre infección por VPH, presencia de lesiones intraepiteliales en cuello uterino y factores de riesgo. Rev Obstet Ginecol Venezuela. 2020;80(4):322-31. Disponible en: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ogv/article/view/20468/144814486776
15. Quesada EB, Revollo PC. Prevalencia genotipo-específica de Virus de Papiloma Humano no vacunables y factores asociados a la infección en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) de Lima, Perú durante el año 2019 [Tesis de pregrado]. [Lima]: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 2023



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

[citado 28 de enero de 2024]. Disponible en:
<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/671320>

16. Zavaleta V. Factores de riesgo de infección cervicouterina por papilomavirus en mujeres atendidas en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria 2019-2020 [Trujillo]: Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO; 2022 [citado 28 de enero de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/9255>
17. Iglesias-Osores S, Serquén-López LM. Virus papiloma humano y factores asociados en pacientes con citología desconocida atendidas en el norte de Perú. Rev Peru Ginecol Obstet. 2020;66(3):1-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v66i2275>
18. Abdi M, Tamiru A, Tilahun T, Tiruneh G, Fite MB. Factors associated with human papillomavirus infections among women living with HIV in public health facilities in Western Oromia, Ethiopia. BMC Womens Health. 2024;24(1):423. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03249-y>
19. Oyouni AAA. Human papillomavirus in cancer: Infection, disease transmission, and progress in vaccines. J Infect Public Health. 2023;16(4):626-31. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2023.02.014>
20. Nelson CW, Mirabello L. Human papillomavirus genomics: Understanding carcinogenicity. Tumour Virus Res. 2023; 15: 200258. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.tvr.2023.200258>
21. Murenzi G, Vuhahula E, Kimambo A, Matiku S, Tuyishime O, Liwa E, et al. High-risk human papillomavirus genotyping in cervical cancers in Tanzania. Infect Agent Cancer. 2024;19(1):35. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13027-024-00596-1>
22. Kusakabe M, Taguchi A, Sone K, Mori M, Osuga Y. Carcinogenesis and management of human papillomavirus-associated cervical cancer. Int J Clin Oncol. 2023;28(8):965-74. Disponible en: <https://doi.org/10.1007%2Fs10147-023-02337-7>
23. Ntanasis-Stathopoulos I, Kyriazoglou A, Lontos M, A Dimopoulos M, Gavriatopoulou M. Current trends in the management and prevention of human papillomavirus (HPV) infection. J BUON Off J Balk Union Oncol. 2020;25(3):1281-5. Disponible en: <https://www.jbuon.com/archive/25-3-1281.pdf>
24. Quinlan JD. Human Papillomavirus: Screening, Testing, and Prevention. Am Fam Physician. 2021;104(2):152-9. Disponible en: https://www.aafp.org/link_out?pmid=34383440
25. Arroyo Mühr LS, Gini A, Yilmaz E, Hassan SS, Lagheden C, Hultin E, et al. Concomitant human papillomavirus (HPV) vaccination and screening for elimination of HPV and cervical cancer. Nat Commun. 2024;15(1):3679. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47909-x>
26. Song J, Ni YH, Fang J, Qu SX, Chen XY, Wu WL, et al. The levels of women's awareness, experience, acceptability and preference for Vaginal Human Papillomavirus (HPV) self-



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

sampling in three provinces of China: a cross-sectional study. BMC Womens Health. 2024;24(1):343. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03186-w>

27. Feng T, Cheng B, Sun W, Yang Y. Outcome and associated factors of high-risk human papillomavirus infection without cervical lesions. BMC Womens Health. 2023;23(1):599. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02764-8>
28. Yachi Leiva AM. Factores de riesgos asociados al diagnóstico del virus papiloma humano en mujeres del Centro de Salud San Ramón 2021-2022 [Internet]. Huancayo: Universidad Peruana Los Andes; 2024 [citado 24 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/7130>
29. De la Cruz Meza RJ. Factores de riesgo asociados al virus papiloma humano en el centro de salud Mariscal Castilla, Rímac 2021 [Internet]. Lima: Universidad Alas Peruanas; 2021 [citado 24 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9391901>
30. Miranda Quinteros KG, Dubon Gómez D de J, Guzmán Méndez AG. Promiscuidad relacionado al Cancer Cervicouterino [Internet] [Tesis de pregrado]. [El Salvador]: Universidad de El Salvador; 2023 [citado 13 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://ri.ues.edu.sv>
31. Hernández, Roberto, Fernández, C., Baptista, Pilar. Metodología de la investigación. Sexta. McGraw Hill; 2016.

 Universidad Norbert Wiener	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
	CÓDIGO: UPNW-EES-FOR-067	VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 01	FECHA: 11/08/2022

Validación del Instrumento:

EXPERTO 1: MENDOZA CAMA JANET GIOVANNA

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [☒]

Aplicable después de corregir [☐]

No aplicable [☐]

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. DNI:

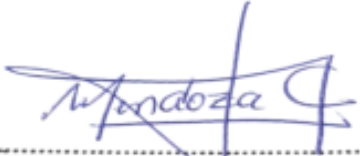
Mendoza Cama Janet Giovanna

Maestra en gestión de los Servicios de la salud

DNI 40554250

Especialidad del validador: Obstetra

04 de Enero del 2025



Janet Mendoza Cama
 MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD
 OBSTETRA
 COP. 18691



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

EXPERTO 2: CHICATA CHAVEZ ANA MARIA

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable []

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. DNI:

Mg. Obstetra Ana Maria Chicata Chavez.

Especialidad del validador: Maestro en Salud Pública



DNI: 70918005.
COP: 40283.
ANA MARIA CHICATA CHAVEZ
Obstetra Auditora
COP 40283
Mg. en Salud Pública

06 de Diciembre del 2024



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022

EXPERTO 3: VEGA GONZALES EMILIO OSWALD

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [☒]

Aplicable después de corregir [☐]

No aplicable [☐]

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. DNI: 80651413

VEGA GONZALES, EMILIO OSWALDO

Especialidad del validador: DOCTOR EN EDUCACIÓN MAESTRÍA EN DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN EN SALUD



Obst. Emilio Vega Gonzales
Maestro en Docencia e Investigación
en Salud
C.O.P. 18102

Firma del Experto Informante

06 de Diciembre del 2024



Universidad
Norbert Wiener

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO:
UPNW-EES-FOR-067

VERSIÓN: 01
REVISIÓN: 01

FECHA: 11/08/2022